

Nerf radial

PLAN :

- I. Introduction.
- II. Anatomie descriptive.
 1. Origine.
 2. Trajet.
 3. Terminaison.
- III. Rapports.
- IV. Branches collatérales.
- V. Branches terminales.
- VI. Territoire d'innervation.
- VII. Anatomie clinique

I. Introduction :

Le nerf radial est un nerf mixte (sensitif et moteur), c'est la plus volumineuse branche terminale du plexus brachial, il assure essentiellement l'extension du membre supérieur, accessoirement il est supinateur et abducteur du pouce, sa lésion est la plus fréquente de tous les nerfs.

II. Anatomie descriptive :

1. Origine :

Il naît du faisceau postérieur (tronc secondaire postérieur) du plexus brachial, dans le creux axillaire, derrière le muscle petit pectoral, ses fibres proviennent des branches antérieures des nerfs spinaux C6- C7-C8-D1.

2. Trajet :

Il chemine à la partie basse et latérale de la fosse axillaire, arrivant au bras il se dirige en bas et en dehors dans le sillon radial au niveau de la région brachiale postérieure, il traverse ensuite le septum intermusculaire brachial latéral pour rejoindre le sillon bicipital latéral.

3. Terminaison :

Il se termine au niveau du coude en une branche superficielle et une branche profonde.

Les 02 branches se poursuivent jusqu'à la main.

III. Rapports :**1. Dans le creux axillaire :**

Le nerf radial est profond, il chemine dans sa partie inféro-latérale, en arrière de l'artère axillaire, et en avant du muscle subscapulaire.

2. Au niveau du bras :

Il pénètre dans la loge postérieure du bras par l'espace axillaire inférieur (ou fente huméro-tricipitale) qui est limité par : l'humérus en dehors, les tendons du grand dorsal et du grand rond en haut, le long triceps est en dedans.

Il chemine dans un canal ostéo-musculaire (canal radial) accompagné par l'artère profonde du bras.

Il quitte cette loge en perforant le septum intermusculaire latéral.

3. Au niveau du coude :

Il parcourt le sillon bicipital latéral, limité médialement par le tendon du biceps brachial et latéralement par le muscle brachioradial, il est accompagné par la branche antérieure de l'artère profonde du bras. Il se termine dans ce sillon en se bifurquant en 02 branches terminales.

IV. Branches collatérales :

- Nerf cutané postérieur du bras.
- Branches du triceps brachial avec : nerf du chef long, nerfs supérieur et inférieur du vaste médial (le nerf inférieur donne une branche pour le muscle anconé), nerf du vaste latéral
- Nerf cutané postérieur de l'avant-bras.
- Nerf du muscle brachio-radial.
- Nerfs du long et du court extenseur radiaux du carpe.

V. Branches terminales :

1. La branche superficielle antérieure : sensitive, elle longe la face profonde du brachio-radial et suit en dehors l'artère radiale, Au 1/3 inférieur de l'avant-bras, elle devient dorsale et sous-cutanée et donne les nerfs digitaux dorsaux latéraux et médiaux des 1^{er} et 2^{ème} ; doigts.
2. La branche profonde postérieure : motrice, elle contourne le col du radius pour rejoindre la loge postérieure de l'avant-bras, en traversant le muscle supinateur, elle se divise entre les 02 couches musculaires de cette loge en 02 rameaux : un rameau court et gros pour les muscles de la couche superficielle, et un rameau long et grêle pour les muscles de la couche profonde, ce rameau se continue par le nerf interosseux postérieur.

VI. Territoire d'innervation :

1. **Motrice** : le nerf radial innerve les muscles de la loge postérieure du bras, la loge postérieure et latérale de l'avant-bras.
2. **Sensitive** :
 - Face postéro-latérale du bras et du coude.
 - La partie médiane de la face postérieure de l'avant-bras.
 - La face dorsale de la main et des doigts (latéralement par rapport à une ligne passant par le médus), à l'exception des deux dernières phalanges des 2^{ème} et 3^{ème} ; doigts.
 - Une petite zone de la base de l'éminence thénar.

VII. Anatomie clinique :

Le nerf radial peut être lésé lors des fractures de la diaphyse humérale, de la palette humérale, du col du radius, et il peut être comprimé par le bord supérieur du muscle supinateur.

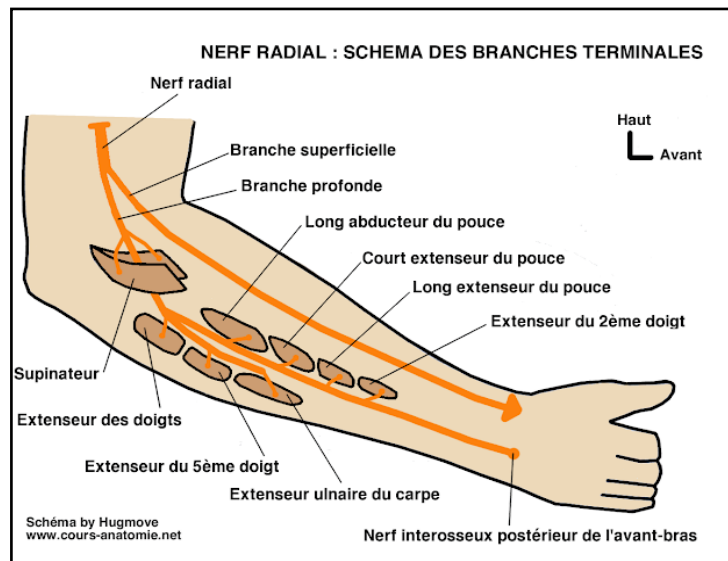
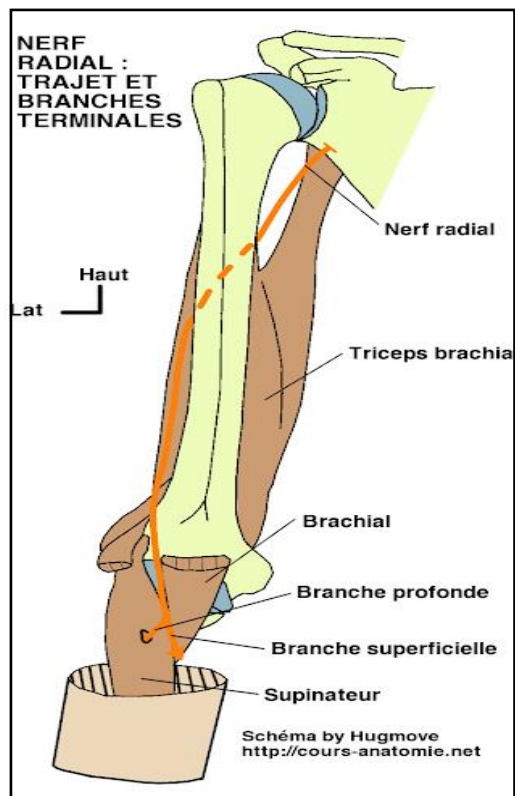
L'atteinte du nerf se caractérise par la main tombante, disparition des réflexes tricipitale et stylo-radial, le diagnostic clinique, paraclinique ainsi que la prise en charge nécessite une bonne connaissance anatomique.

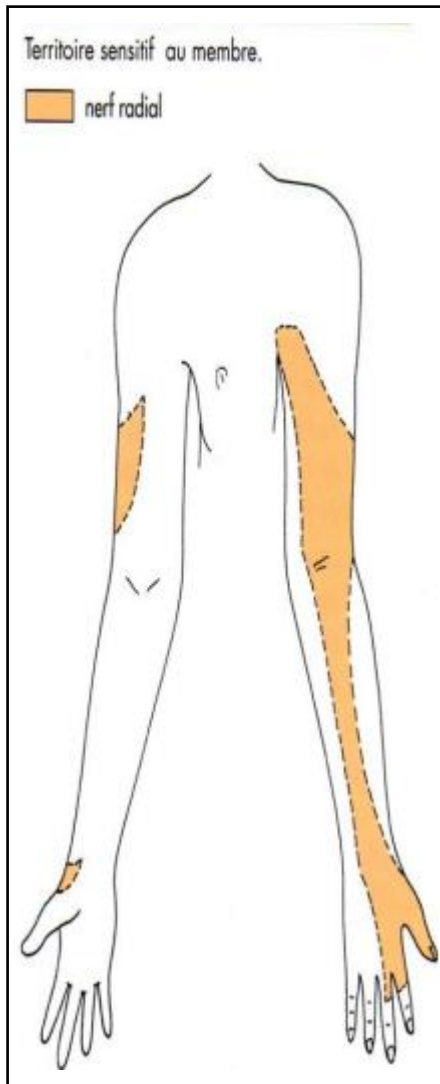
Bibliographie :

Hammoudi SS. Le cours d'anatomie.fasc.2 appareil locomoteur membre inférieur. ISBN 2008.

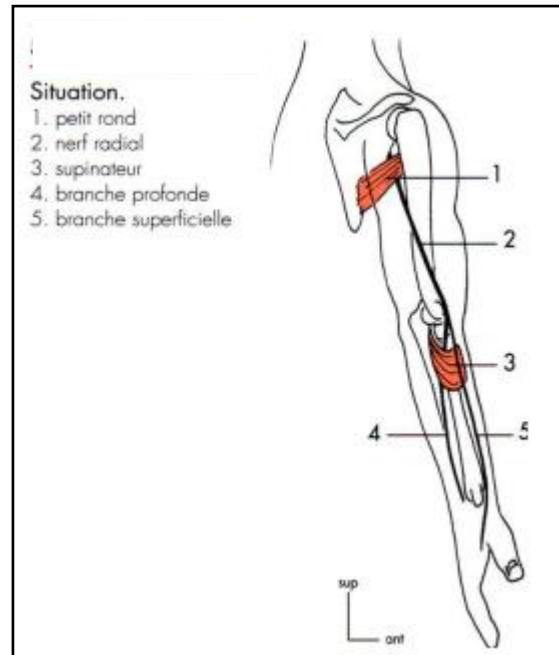
Kamina P. Précis d'anatomie clinique. Tome I. Edition Maloine Paris 2022. France.

J. BRIZON et J. CASTAING, les feuillets d'anatomie, vaisseaux du membre supérieur, fascicule VI, Edition MALOINE.





Vue ventrale et dorsale du membre thoracique



vue latérale du membre thoracique